

TRIAJE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

María del Mar Suárez Gago, Cesáreo Álvarez Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda asistencial en los Servicios de Urgencias hace necesario disponer de un sistema de clasificación de los pacientes, o triaje estructurado, que permita identificarlos en base a su prioridad asistencial. Esta prioridad está en función del riesgo vital de cada paciente, pero también de otras variables, como el dolor.

Los sistemas de triaje estructurado se caracterizan por ser dinámicos, fáciles de aplicar, estandarizados y reproducibles independientemente del personal que lo aplique o del centro donde se utilice. Los profesionales que realizan esta labor deben estar bien entrenados. En nuestro entorno esta función recae fundamentalmente en la enfermería.

SISTEMAS DE TRIAJE

Existen cinco sistemas de triaje estructurado:

- Sistema australiano de triaje (ATS).
- Escala canadiense de triaje y gravedad para los servicios de urgencias (CTAS).
- Índice de gravedad de urgencias (ESI).
- Modelo andorrano de triaje (MAT).
- Sistema Manchester de triaje (MTS).

Los más usados en España son el Sistema Manchester y el sistema Andorrano modificado (también llamado sistema español).

MANCHESTER TRIAJE SYSTEM (MTS)			
Nivel	Color	Categoría	Tiempo de atención
NIVEL I	ROJO	REANIMACIÓN	INMEDIATO
NIVEL II	NARANJA	MUY URGENTE	ANTES DE 10 MINUTOS
NIVEL III	AMARILLO	URGENTE	ANTES DE 60 MINUTOS
NIVEL IV	VERDE	MENOS URGENTE	ANTES DE 120 MINUTOS
NIVEL V	AZUL	NO URGENTE	ANTES DE 240 MINUTOS

Nunca se plantea un sistema de triaje en base a diagnósticos médicos, ya que éstos son el resultado final de la asistencia médica, sino a escalas de gravedad específica (como en CTAS con las escalas de asma, de disnea, de coma...) o de síntomas guía dentro de protocolos o presentaciones clínicas con algoritmos específicos (como en el ESI o MAT) y todos ellos con un soporte informático que permite una rápida clasificación y estratificación de cada paciente tras la recogida de una información básica en la sala de triaje.

Sistema Español de Triage: SET			
Nivel	Color	Categoría	Tiempo de atención
NIVEL I	Azul	Reanimación	Inmediato
NIVEL II	Rojo	Emergencia	Inmediato enfermería Médicos 7 minutos
NIVEL III	Naranja	Urgente	30 minutos.
NIVEL IV	Verde	Menos urgente	45 minutos.
NIVEL V	Negro	No urgente	60 minutos

NIVELES DE TRIAJE

Todos los sistemas de triaje comentados tienen en común una estratificación en 5 niveles o categorías.

- Nivel I. Situaciones que requieren medidas de resucitación o con riesgo vital inmediato.
- Nivel II. Situaciones de emergencia vital tiempo dependientes (15 minutos) y con inestabilidad fisiológica o dolor muy intenso; incluye tratamiento como trombolisis o aplicación de antídotos.
- Nivel III. Situaciones urgentes, con riesgo vital potencial (en 30 minutos) con necesidad de múltiples exploraciones complementarias y terapéuticas pero con estabilidad fisiológica del paciente.
- Nivel IV. Situaciones menos urgentes que precisan una exploración diagnóstica o terapéutica.
- Nivel V. Situaciones menos urgentes o no urgentes, no suelen requerir exploraciones complementarias y que permiten demoras en la atención mayores de 4 horas.

ORGANIZACIÓN DEL TRIAJE

La enfermera de triaje debe de tener un fácil acceso al área de recepción administrativa y al área de espera de pacientes. Sus funciones son: recibir al paciente en un ambiente confidencial, recoger sus quejas y sus constantes vitales, asignar la prioridad asistencial, informar al médico responsable, informar al paciente y familiares, y reevaluar periódicamente a los pacientes pendientes de valoración médica, manteniendo control visual del área de espera.

Se dice que hay sobretraje cuando un paciente es clasificado en un nivel de prioridad mayor del que le corresponde. Esto no supone un riesgo para él, pero sí para los otros pacientes que esperan ser atendidos. Por el contrario el subtraje significa asumir un mayor riesgo para el propio paciente, al aumentar la demora en su atención. Este riesgo se minimiza con la reevaluación periódica.

Se ha establecido que los pacientes con:

- Nivel I precisan reevaluación continúa.
- Nivel II precisan reevaluación cada 15 minutos.
- Nivel III precisan reevaluación cada 30 minutos.
- Nivel IV precisan reevaluación cada 60 minutos.
- Nivel V precisan reevaluación cada 120 minutos, en esta reevaluación se aconseja el sobretraje.

Los sistemas de triaje estructurado permiten obtener los llamados “índices de calidad del triaje” que permiten monitorizar de forma continua el correcto funcionamiento del sistema. De éstos índices destacan tres.

- “tiempo de espera antes de ser atendido en el triaje” (recomendado menor de 10 minutos).
- “tiempo de duración del triaje” (recomendado menor de 5 minutos).
- “porcentaje de pacientes que dejan el hospital sin ser atendidos por el equipo médico” (se recomienda sea menor del 2%).

En resumen, un sistema de triaje estructurado es una herramienta imprescindible en la gestión de los servicios de urgencias modernos, tanto para garantizar la seguridad del paciente como para aumentar la satisfacción de los usuarios y del personal sanitario, racionalizando el consumo de recursos y procurando la mejora en la calidad asistencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanchez Bermejo R, Cortés Fadrique C, Rincón Fraile B, Fernandez Centeno E, Peña Cueva S, De las Heras Castro EM. El triaje en Urgencias en los Hospitales Españoles. *Emergencias* 2013; 25: 66-70.
- Gomez Jimenez J. Clasificación de pacientes en los servicios de Urgencias y emergencias: Hacia un modelo de triaje estructurado de urgencias y emergencias. *Emergencias* 2003; 15: 165-174.
- SEMES-SET. Sistema español de triaje en urgencias y emergencias. Disponible: [http:// www.semes.org/set/documentos.php](http://www.semes.org/set/documentos.php).